

Datos Personales							
Nombre:	MARIA GABRIELA ECHEVERRIA MUÑOZ	Sexo Biológ.:	M	F. Nacimiento:	2011-10-16	Edad	14 Años, 2 Meses, Y 24 Días
Identificación:	TI - 1077235980	Lateralidad:	Diestro	Estado Civil:	Soltero	Ocupación:	ESTUDIANTE
Correo Electrónico:	Lletynna26@hotmail.Com - 1077235980			Dirección:	CRA 38 # 5E-99 FRANCISCO EL HOMBRE		
Departamento:	CESAR	Municipio:	VALLEDUPAR		Zona:	Urbana	
Empresa:	EPS005 - (EPS SANITAS)						
En Caso De Emergencia Llamar A:		LEITI MUÑOZ - Parentesco (madre) - Teléfono (3108651467)					

Apertura psicología del 2025-08-03 15:02:58: 14 años, 2 meses, y 24 días

DATOS GENERALES

Remisión

Particular

Código de consulta

890208 - CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR PSICOLOGIA

Motivo de Consulta

Refiere la madre "me llamaron del colegio que la niña tuvo una crisis, dio un grito fuertísimo en la piscina desgarrador, entró en estado de shock de pánico, temblaba, y le decía a las amigas que le buscaran un martillo que ella se quería hacer daño".
Refiere la paciente "Tuve un comportamiento completamente extraño a mi persona, estaba practicando un baile y tenía miedo, estrés, frustración porque no aprendía los pasos, sentí hormigueo, especie de temblor, como si me hubiese inyectado adrenalina, pensamientos raro, sentía que el pecho y el corazón me temblabas, especie de estrés sin razón aparente, no estaba molestabam con nadie", "por un momento quise reprimirlo pero estaba con mis amigas, entonces me fui a la cancha a gritar para ver si se me pasaban esas sensaciones y emociones tan raras".

Enfermedad Actual

Paciente preadolescente que presenta episodios agudos de ansiedad con síntomas físicos intensos (temblores, hormigueo, palpitaciones), ideación autolesiva, aislamiento social, baja autoestima, rechazo corporal, desregulación emocional y cuestionamientos existenciales atípicos para su edad. Se reportan barreras afectivas en el vínculo familiar bajo un estilo de crianza autoritario, así como posible antecedente de trauma no resuelto. Se observan manifestaciones conductuales compatibles con pica (a probado tierra, colonia, pasta, botón jabón, liquido con el que limpio las gafas) en etapas previas. La sintomatología se ha agudizado en contextos escolares, con necesidad de intervención clínica continua para contención emocional y evaluación Neuropsicológica.

ANTECEDENTES

Médicos Personales

Quirúrgico

No Refiere

Traumáticos

Ninguno

Paraclínicos

No Refiere

Patología

Dermatitis Atópica

Tóxicos

No Refiere

Medicación

No Refiere

Hospitalizaciones

No Refiere

ANTECEDENTES

Prenatales

Edad De La Madre En El Embarazo

26 Años

Único Embarazo

Primer

Uso De Planificación En El Momento Del Embarazo

No

Enfermedades De La Madre

No

El Embarazo Fue Controlado Por Atención Médica

Si

Estado De La Madre Durante El Embarazo

Normal

ANTECEDENTES

Natales

Tipo De Nacimiento Cesarea	Causa De La Cesárea Voluntaria
Uso De Maniobras De Reanimación No	Llanto Al Nacer Si

ANTECEDENTES

Posnatales

Hospitalizaciones Recién Nacido No Refiere
--

ANTECEDENTES

Desarrollo Psicomotor

Control Cefálico 2M	Rolado 3M
Sedente Solo 4M	Gateo 6M
Bípodo Sin Ayuda 8M	Marcha 9M
Lenguaje Verbal 24M	Lenguaje Verbal Fluido 5 AÑOS

ANTECEDENTES

Médicos Familiares

Depresión Abuela Materna	Ansiedad No Refiere
Demencia Abuela Materna	Alcoholismo No Refiere
Drogadicción Primo Materno	Discapacidad Intelectual No Refiere
Patológicos Hipertensión Padre, Abuela Paterna, Insuficiencia Renal Abuelo Paterno, Abuela Paterna Cáncer.	Otros Bipolaridad Abuela Materna, Orientación Homosexual Familia Materna Un Primo, Prima Tercera Paterna.

Áreas de Ajuste y/o Desempeño

Historia educativa La paciente se encuentra actualmente cursando el grado octavo en el Colegio María Montessori, donde presenta un rendimiento académico satisfactorio. Si bien no mantiene una relación cercana con todos sus compañeros, ha establecido un vínculo significativo con un grupo específico de compañeras con quienes comparte mayor afinidad y confianza, mostrando una interacción social funcional dentro de ese círculo. En cuanto a sus intereses académicos, ha manifestado especial afinidad por las asignaturas de Ética, Filosofía e Inglés, áreas en las que demuestra mayor motivación y participación.
Historia laboral No aplica
Historia familiar La paciente vive actualmente con su padre, el señor Juan Echeverría (43 años); su madre, la señora Leiti Muñoz (39 años); y su hermana menor, María Mónica Echeverría (7 años). Se describe un entorno familiar estructurado, con buena relación entre los miembros del núcleo, presencia de límites claros y una crianza orientada a la creación constante de hábitos y rutinas específicas.
Historia social No aplica
Historia socio-afectiva Refiere la madre que durante la infancia, la paciente se caracterizó por ser una niña alegre y participativa en opinión. Sin embargo, a partir de los 8 años comenzó a evidenciar cambios en su estado emocional, mostrando mayor timidez y sensibilidad frente a diversas situaciones. A los 11 años se incrementó el aislamiento social, limitando sus interacciones a un grupo reducido. En ese entonces, su vínculo social era principalmente con niños; actualmente, mantiene relaciones cercanas con un grupo específico de compañeras, sin presentar una integración social amplia con todo su entorno escolar.

EVALUACIÓN PSICOLÓGICA

Evaluación psicológica inicial La paciente se encuentra actualmente en proceso de evaluación clínica debido a la presencia de episodios emocionales agudos, conductas de aislamiento, dificultades en la expresión emocional y posible disforia corporal. Durante las entrevistas se ha evidenciado un estilo reflexivo, pensamiento complejo para su edad cronológica, intereses particulares y una sensibilidad emocional elevada. Presenta manifestaciones compatibles con episodios de ansiedad intensa, incluyendo síntomas congruentes con crisis de pánico. Asimismo, se han identificado
--

indicadores que sugieren la necesidad de descartar condiciones del espectro autista de alto funcionamiento, como el trastorno de Asperger (actualmente clasificado como TEA grado 1), dada la rigidez en patrones de pensamiento, el estilo de socialización restringido y las particularidades en el lenguaje y procesamiento emocional.

Se sugiere la aplicación de una **evaluación Neuropsicológica completa** para identificar el perfil cognitivo de la paciente, así como la **administración del instrumento ADOS-2** (Autism Diagnostic Observation Schedule), con el fin de confirmar o descartar la presencia de Trastorno del Espectro Autista grado 1. La aplicación de estas pruebas es **necesaria para lograr una mayor claridad diagnóstica en el contexto de la psicología clínica** y poder establecer una intervención clara, eficaz y basada en las necesidades reales tanto de la paciente como de su entorno familiar.

Se considera indispensable el acompañamiento cercano y presencial de sus padres, quienes constituyen su principal red de apoyo y protección emocional, especialmente en esta etapa del proceso terapéutico.

Interconsultas e Intervenciones

Intervención psiquiátrica

No refiere

Intervención neurológica

No refiere

Intervención neuropsicológica

No refiere

Otras intervenciones

No refiere

EXAMEN MENTAL

Examen Mental

La paciente ingresa a consulta con un saludo frío y distante. Se presenta con vestimenta e higiene acordes a su edad cronológica. Se encuentra orientada en persona (auto) y en tiempo, espacio y situación (alopsíquicamente). Su pensamiento es lógico, organizado y estructurado, sin alteraciones formales ni de contenido que indiquen procesos delirantes. El lenguaje es fluido, articulado y con capacidad argumentativa; responde con claridad, aunque mantiene un tono emocional plano y limitado contacto visual. El juicio se mantiene coherente, con conciencia parcial de sus estados emocionales. Refirió episodios de pensamientos suicidas sin intención ni planes concretos, lo que representa un factor de riesgo que requiere seguimiento clínico. No se evidencian alteraciones sensorio-perceptivas como alucinaciones. El afecto se observa restringido, con tendencia a la racionalización de sus emociones. Se destaca un estilo cognitivo introspectivo, preguntas existenciales frecuentes y una sensibilidad marcada hacia temas sociales y espirituales. Se evidencia ansiedad elevada, especialmente ante la frustración o la sobrecarga emocional, y presencia de síntomas congruentes con episodios de pánico. La paciente también presenta disconformidad corporal e indicadores que ameritan la exploración de posibles rasgos del espectro autista de alto funcionamiento.

Ciclos del Sueño

Alteraciones en los ciclos sueño (pesadillas, sueños raros con leones)

Apetito

Alimentación controlada por apetito elevado

Actividades de Autocuidado

Independiente

IMPRESIÓN DIAGNOSTICA

Establecido por primera vez

Si

Objeto de atención clínica

PLAN DE INTERVENCIÓN

Plan de Intervención

Objetivo General

No aplica (en espera de informe de Pruebas Neuropsicológicas)

Objetivos Específicos

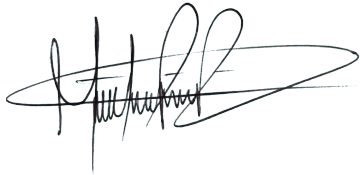
No aplica (en espera de informe de Pruebas Neuropsicológicas)

Sugerencias e Interconsultas

- Interconsulta con Neuropsicología Clínica
- Interconsulta con Psiquiatría

Observaciones y Recomendaciones

- Iniciar proceso psicoterapéutico individual enfocado en regulación emocional, fortalecimiento del autoconcepto y habilidades de afrontamiento.
- Aplicar batería de evaluación neuropsicológica para identificar su perfil cognitivo y detectar posibles dificultades en funciones ejecutivas, atención y procesamiento emocional.
- Aplicación del instrumento **ADOS-2** para confirmar o descartar diagnóstico dentro del espectro autista (Asperger o Autismo nivel 1).
- Acompañamiento familiar para ajustar pautas de crianza, mejorar la comunicación afectiva y revisar el estilo parental predominante.
- Coordinar con el colegio un plan de seguimiento emocional que incluya protocolos de actuación ante crisis, contención emocional y revisión del entorno social inmediato.
- Realizar interconsulta con psiquiatría infantil en caso de aparición de nuevas crisis, ideas suicidas persistentes o aumento del riesgo emocional.



DRA. MARIA ISABEL PUMAREJO

Psicóloga clínica
Tarjeta Profesional: 259542
Mag. TP3G - VIU



PRASCA
CENTER